

woek gesundheit pflege gesamtdossier v0 1

WIRKUNGSÖKONOMIE

FÜR MENSCH, PLANET UND DEMOKRATIE

Gesundheit & Pflege

Gesamtdossier mit Beispielen, Datenquellen, Berechnungslogik und Umsetzungspfaden

Leitsatz: Gesundheit ist kein medizinisches Ereignis, sondern ein gesellschaftlicher Zustand. Sie entsteht durch Prävention, Resilienz, Stabilität, Teilhabe, Pflege und gutes Leben.

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck des Dossiers
2. Datenquellen
3. Beispielrechnungen
4. Tool-Logik
5. Akteursperspektiven
6. Politische Umsetzung
7. Quellen

1. Zweck des Dossiers

Dieses Dossier übersetzt das Konzept Gesundheit & Pflege in Beispiele, Datenquellen, Berechnungslogiken und Umsetzungsoptionen. Es richtet sich an Politik, Verwaltung, Kommunen, Krankenkassen, Pflegeakteure, Unternehmen, Stiftungen, Wissenschaft und Öffentlichkeit.

2. Datenquellen und Vertrauensstufen

3. Beispielrechnungen

Hitzeschutz im Quartier

Investition in Schatten, Wasserpunkte, Grün und Nachbarschaftskommunikation. Vermiedene Wirkung: weniger Notfälle, geringere Belastung vulnerabler Gruppen, weniger Pflege- und Krankenhauslast. Formel: erwartete Risikoreduktion × Basisfälle × Fallkosten + Lebensqualitätsnutzen + Resilienzwert.

Datenbedarf: Basisrate, Zielgruppe, erwartete Risikoreduktion, Kosten je Ereignis, Zeithorizont, Unsicherheitsband.

Output: Gesundheitswirkungswert, vermiedene Kosten, Resilienzbeitrag, SDG-/SDG+-Bezug, Datenschutzstatus.

Betriebliche psychische Sicherheit

Investition in Führung, Arbeitszeitgesundheit, Konfliktprävention und Zugang zu Beratung. Vermiedene Wirkung: weniger Burnout, weniger Krankheitstage, geringere Fluktuation, höhere Teamstabilität. Formel: reduzierte Ausfalltage × Kosten pro Ausfalltag + reduzierte Fluktuationskosten + Stabilitätsnutzen.

Datenbedarf: Basisrate, Zielgruppe, erwartete Risikoreduktion, Kosten je Ereignis, Zeithorizont, Unsicherheitsband.

Output: Gesundheitswirkungswert, vermiedene Kosten, Resilienzbeitrag, SDG-/SDG+-Bezug, Datenschutzstatus.

Pflegequartier

Kombination aus Tagespflege, ambulanter Versorgung, Angehörigenentlastung, Sturzprävention und digitalem Monitoring. Vermiedene Wirkung: Krankenhausaufenthalte, Heimübergänge, Angehörigenüberlastung, Einsamkeit.

Datenbedarf: Basisrate, Zielgruppe, erwartete Risikoreduktion, Kosten je Ereignis, Zeithorizont, Unsicherheitsband.

Output: Gesundheitswirkungswert, vermiedene Kosten, Resilienzbeitrag, SDG-/SDG+-Bezug, Datenschutzstatus.

Schulgesundheits

Bewegung, Ernährung, psychische Stabilität, Schulsozialarbeit und digitale Mobbingprävention. Vermiedene Wirkung: spätere Gesundheitsrisiken, Fehlzeiten, psychische Krisen, Bildungsabbrüche.

Datenbedarf: Basisrate, Zielgruppe, erwartete Risikoreduktion, Kosten je Ereignis, Zeithorizont, Unsicherheitsband.

Output: Gesundheitswirkungswert, vermiedene Kosten, Resilienzbeitrag, SDG-/SDG+-Bezug, Datenschutzstatus.

4. Tool-Logik

Die Tool-Suite arbeitet mit modularen Checks. Jedes Modul trennt Eingaben, Annahmen, Datenqualität, Wirkungsbereiche, Unsicherheiten und Ergebnisdarstellung. Es gibt keine Personenscores. Ergebnisse gelten für Programme, Räume, Maßnahmen oder Institutionen.

5. Akteursperspektiven

Bürger:innen: Zugang, Würde, Prävention, Datenschutz, keine Schuldlogik.

Kommunen: Gesundheitsräume, Pflegequartiere, Hitzeschutz, Begegnung, Präventionshaushalt.

Krankenkassen und Pflegekassen: von Kostenverwaltung zu Gesundheitswirkung.

Unternehmen: Arbeitsgesundheit, psychische Sicherheit, Produkte und Lieferketten.

Politik: Rahmen, Finanzierung, Pilotierung, Rechtsschutz, Wirkungsberichte.

Wissenschaft: Evaluation, Datenqualität, Methoden, Missbrauchsschutz.

6. Politische Anschlussfähigkeit

Quellen und Anschlussdokumente

Diese Arbeitsfassung ist ein öffentliches Fach- und Konzeptsdokument der Wirkungsökonomie. Sie ersetzt keine medizinische, rechtliche oder steuerliche Beratung. Für Diagnosen, Behandlung und individuelle Gesundheitsentscheidungen sind qualifizierte Fachstellen zuständig.

Weber, Natalie: Die neue Ordnung des Wohlstands. Arbeitsfassung 2026. Kapitel 68 Gesundheit, Kapitel 69 Pflege, Kapitel zu Wirkungshaushalt, Resilienzstaat und Wirkungsfonds.

Weber, Natalie: Systemmodell der Wirkungsökonomie, 2025. Spalte 7 Gesundheit, Pflege & Leben.

Weber, Natalie: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0, 2026.

World Health Organization (WHO): Constitution of the World Health Organization; Social determinants of health; One Health.

OECD: Health at a Glance 2025: Germany und Health expenditure on prevention and primary healthcare.

Destatis: Gesundheitsausgaben 2024; Pflegebedürftige in Deutschland 2023; Gesundheits- und Pflegestatistiken.

Bundesministerium für Gesundheit: Informationen zu Gesundheit, Prävention, Pflege und Krankenhausstrukturreform.

Robert Koch-Institut / Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Gesundheitsindikatoren, Prävention, psychische Gesundheit, soziale Determinanten.

EU / Europäische Kommission: Europäische Gesundheitsdatenräume, EU4Health, Klima- und Gesundheitsbezüge, einschlägige Gesundheits- und Digitalrechtsakte.

Dokumenttyp | Gesamtdossier

Autorin | Natalie Weber

Referenz | Wirkungsökonomie

Version / Stand | v0.1 · 24. Mai 2026

Status | Arbeitsfassung / Diskussionsfassung

Datenquelle | Verwendung

Destatis Gesundheitsausgaben | Makroausgaben, Kostenentwicklung, Trägerstruktur, Gesundheitsausgaben je Einwohner:in.

Destatis Pflegestatistik | Pflegebedürftige, Pflegeformen, stationär/ambulant, Pflegeeinrichtungen.

OECD Health at a Glance | Internationaler Vergleich zu Ausgaben, Prävention, Versorgung, Risikofaktoren.

WHO Social Determinants / One Health | Konzeptionelle Grundlage für nicht-medizinische Gesundheitsdeterminanten und planetare Gesundheit.

RKI / GBE | Indikatoren zu Gesundheit, Krankheit, Prävention, psychischer Gesundheit und Bevölkerungsgesundheit.

Kassen- und Versorgungsdaten | Versorgungspfade, Präventionsprogramme, Krankheitstage, chronische Erkrankungen, Medikations- und Behandlungsdaten – nur aggregiert/datenschutzkonform.

Kommunale Daten | Hitze, Lärm, Grünflächen, Mobilität, Begegnungsräume, Pflegezugang, Sozialstruktur.

Hinweis Alle Berechnungen sind modellhafte Demonstrationen. Sie ersetzen keine medizinische, gesundheitsökonomische, rechtliche oder haushaltspolitische Prüfung.

Tool | Funktion

Gesundheitswirkungscheck | Bewertet Maßnahmen nach Prävention, Zugang, Teilhabe, Lebensqualität, Resilienz und Nebenwirkungen.

Präventionswirkungsrechner | Schätzt vermiedene Schäden und Kosten durch Präventionsmaßnahmen.

Pflegewirkungscheck | Bewertet Stabilisierung, Würde, Entlastung, Selbstständigkeit, Fachkräftegesundheit.

Kommunaler Gesundheitsraum-Check | Prüft Quartiere nach Hitze, Grün, Bewegung, Versorgung, Begegnung, Sicherheit und Barrierefreiheit.

Mental-Health-Reflexionsmodul | Nicht-diagnostisches Modul für Belastungsräume, Wartezeiten, niedrigschwellige Hilfe und Schutzfaktoren.

Ebene | Aufgabe für Politik und Umsetzung

Aufgabe der Politik | Den Rahmen schaffen, damit Gesundheit nicht nur als Behandlungskostenblock erscheint, sondern als präventive, soziale, ökologische und demokratische Systemleistung sichtbar wird.

Politische Rahmenbedingungen | Gesundheitswirkungshaushalte, Präventionsbudgets, Pflegewirkung, kommunale Gesundheitsräume, Datenstandards, Datenschutz, Versorgungssicherheit und unabhängige Evaluation.

Ausgestaltungsspielraum | Parteien können unterschiedliche Wege wählen: stärkere kommunale Steuerung, mehr Kassenautonomie, Präventionsboni, öffentliche Fonds, Versicherungsmodelle, Modellregionen oder gesetzliche Mindeststandards.

Zielkonflikte | Freiheit und Schutz, Prävention und Bevormundungsrisiko, Datenschutz und Frühwarnsysteme, Kostendruck und Qualität, Zentralisierung und Nahversorgung, Innovation und Solidarität müssen demokratisch ausbalanciert werden.

Rollenverteilung | EU, Bund, Länder, Kommunen, Krankenkassen, Pflegekassen, Leistungserbringer, Unternehmen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Bürger:innen tragen unterschiedliche Aufgaben.

Übergang und Schutz | Pilotregionen, Härtefallregeln, Datenschutz, keine Personen-Scores, keine Sanktionierung von Krankheit, Schutz vulnerabler Gruppen, Fachkräfteschutz und digitale Barrierefreiheit.

Evaluation und Korrektur | Wirkungsberichte, Gesundheitswirkungsindex, Präventionswirkungsrechner, Pflegestabilitätsindikatoren, öffentliche Konsultation und Revisionszyklen.

Parteilpolitische Anschlussfähigkeit | Liberale, konservative, sozialdemokratische, grüne, linke, kommunale und wirtschaftsnahe Perspektiven können unterschiedliche Ausgestaltungen wählen, solange Wirkung sichtbar und korrigierbar bleibt.